

Task 5: Атаксія. Ураження мозочка(ok)

Відповідальний підрозділ: Кафедра неврології та нейрохірургії
Автори:

- 1. Солодовнікова Юлія Олександрівна — розробка завдання , внутрішнє рецензування (відносна частка участі — 50%)
- 2. Бабич Еліза Віталіївна — розробка завдання , внутрішнє рецензування (відносна частка участі — 50%)

Компетенції:
Мета завдання: Оцінити навички встановлення топічного діагнозу
Обладнання:
Не потрібно
Витратні матеріали:
Не потрібно
Брифінг

До вас звернувся 47-річний чоловік зі скаргами на нестійкість при ходьбі, відчуття «п'яної» ходи, періодичне запаморочення та труднощі з координацією рухів.

ok
Текст завдання

До вас звернувся 47-річний чоловік зі скаргами на нестійкість при ходьбі, відчуття «п'яної» ходи, періодичне запаморочення та труднощі з координацією рухів. Симптоми поступово наростали протягом останніх кількох місяців. Також пацієнт зазначає, що йому стало важче писати, застібати гудзики та брати дрібні предмети. У неврологічному статусі: патологічні рефлексії не викликаються, м'язова сила 5/5 б. у всіх кінцівках. Хода з широко розставленими ногами та руками, що надмірно високо підіймаються, нерівномірними по довжині кроками, похитуванні з боку в бік. Чутливих порушень немає.

- 1. Зберіть скарги, анамнез хвороби та життя.
- 2. Проведіть координаторні проби (Ромберга, пальце-пальцеву, п'яtkово-колінну).
- 3. Вкажіть яка структура ЦНС уражена, та визначте подальшу тактику.

ok

Чеклист

1. -Привітатися, представитися, запитати як може звертатися до пацієнта Значення: 2%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
2. -Уточнити скарги Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
3. -Зібрати анамнез хвороби Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
4. -Зібрати анамнез життя Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
5. -Доступно пояснити необхідність та техніку проведення координаторних проб. Запитати дозволу на проведення. Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
6. -Провести тест тандемної ходи, доступно пояснити техніку виконання. Значення: 13%	

☐ Не виконано	☐ Виконано
7. -Провести пробу Ромберга Значення: 13%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
8. - Провести пальце-носову пробу Значення: 13%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
9. -Провести пальце-пальцеву пробу Значення: 13%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
10. - Інтерпретувати результати Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
11. -Вказати яка структура ЦНС уражена, аргументувати (наявність основних симптомів астазія, абазія, інтенційний тремор, адіадохокінез, скандована мова) Значення: 16%	
☐ Не виконано	☐ Виконано

Інструкції для актора

Лікар (студент)	Пацієнт (актор)
Добрий день. Що вас турбує?	Добрий день. Останнім часом я почав погано тримати рівновагу, хода якась як п'яна.
Скільки це триває?	Вже кілька місяців. Спочатку було легке похитування, а зараз часто падаю.
Чи буває запаморочення?	Так, періодично крутиться голова.
Чи є інші симптоми?	Так, стало важче писати, застібати гудзики, беру речі — а вони випадають.
Є слабкість у руках або ногах?	Ні, сил наче достатньо.
Як давно це почалося?	Приблизно 4–5 місяців тому, поволі ставало гірше.
Чи є якісь супутні хвороби?	У мене була гіпертонія, але зараз тиск контрольований. Більше нічого серйозного не пам'ятаю.
Чи вживаєте алкоголь?	Іноді, але останнім часом зовсім перестав.
Чи були травми голови або шиї?	Ні, не пригадую.
Дозвольте провести кілька проб на координацію рухів.	Так, звісно.
Станьте, будь ласка, рівно, ноги разом, очі закрийте. (Проба Ромберга)	— (похитується або падає)
Тепер торкніться пальцем кінчика свого носа, потім мого пальця. (Пальце-пальцева проба)	— (рухи повільні, з промахуваннями і з вираженим тремтінням при досягненні предмету)
Покладіть п'яту однієї ноги на коліно іншої та проведіть вниз по голішці. (П'яtkово-колінна проба)	— (рух неточний, хаотичний, зі зсувами вбік)
При огляді у вас спостерігаються симптоми атаксії, такі як астазія, абазія, інтенційний тремор, адіадохокінез, скандована мова. Необхідно зробити МРТ головного мозку для виключення ураження мозочка або його шляхів.	Добре, я зрозумів. Дякую.

Лікар (студент)	Пацієнт (актор)
Добрий день. Що вас турбує?	Добрий день. Останнім часом я почав погано тримати рівновагу, хода якась як п'яна.
Скільки це триває?	Вже кілька місяців. Спочатку було легке похитування, а зараз часто падаю.
Чи буває запаморочення?	Так, періодично крутиться голова.
Чи є інші симптоми?	Так, стало важче писати, застібати гудзики, беру речі — а вони випадають.
Є слабкість у руках або ногах?	Ні, сил наче достатньо.

Як давно це почалося?	Приблизно 4–5 місяців тому, поволі ставало гірше.
Чи є якісь супутні хвороби?	У мене була гіпертонія, але зараз тиск контрольований. Більше нічого серйозного не пам'ятаю.
Чи вживаєте алкоголь?	Іноді, але останнім часом зовсім перестав.
Чи були травми голови або шиї?	Ні, не пригадую.
Дозвольте провести кілька проб на координацію рухів.	Так, звісно.
Станьте, будь ласка, рівно, ноги разом, очі закрийте. (Проба Ромберга)	— (похитується або падає)
Тепер торкніться пальцем кінчика свого носа, потім мого пальця. (Пальце-пальцева проба)	— (рухи повільні, з промахуваннями і з вираженим тремтінням при досягненні предмету)
Покладіть п'яту однієї ноги на коліно іншої та проведіть вниз по гомілці. (П'яtkово-колінна проба)	— (рух неточний, хаотичний, зі зсувами вбік)
При огляді у вас спостерігаються симптоми атаксії, такі як астазія, абазія, інтенційний тремор, адіадохокінез, скандована мова. Необхідно зробити МРТ головного мозку для виключення ураження мозочка або його шляхів.	Добре, я зрозумів. Дякую.